

INDICADO POR: Dr. Pedro☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

EDVANDRO DE SOUZA SILVAIDADE: 46a PESO: 130 ALTURA: 1,92 PROFISSÃO: Gerente Coml; Aposentado pelaSINTOMAS: Dono; SED; Anke dos hemisfério D; Dor no DCE; defic.
Boca seca;QUEIXAS: AVC há 3 anos e meio - ↓ FM à D e Buxia facial ?? à Esq.MEDICAMENTOS: HAS (Triplixam + Indapem, Amlodipino, Perindopril); Selegrak,
APS; Espino-relaxona; Glifage; Glaxoartem;MÉDICO: Dr. Pedro / Dra. Marcelle Sa (cardio)MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () NEXERCÍCIO FÍSICO: Academia diária

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 21h30' 22h HORA QUE ACORDA: 04h50'COCHILO ☒ S () N DORME ACOMPANHADO: () S () N ☒ EVENTUALMENTETEM FILHOS: () S ☒ N / DORMEM NO QUARTO: () S () N PET NO QUARTO: () S ☒ NBEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N desde o AVC passou.FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO/NOITE: 3x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: nao MALLAMPATI: IAH: 34.1h SPO2: 74% ↓ N3: 71.PATOLOGIAS ASSOCIADAS: HAS DM, Colerend; 79 despietas: 14/hv 4 N2: 64.7 tempo Apneia 37seg / ↓ Efe: 77.CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA IDO: 47.9/h IDO-REM: 74p/h.HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: provável

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S ☒ N SPO2 C/ CPAP: — PRESSÃO NO EXAME: —18/02/2026 - Análise de Maix Pico x (G)
Auto 4 a 12 cmhro.